

입원환자 급식지침(제4조 관련)

1. 식이요법

영양불량은 망각증·불안증·신경과민증·우울증 등의 정신과적 증상을 악화시키거나 집중력 부족이나 생활의욕의 상실 등과 같은 신경장애를 유발하고 두뇌와 정신력의 작용을 감퇴시키는데 까지 발전시킨다.

반대로 영양과다는 대사증후군을 유발하여 환자의 심혈관질환의 위험성을 높일 수도 있다.

그러므로 환자식사는 식욕의 정상여부에 관계없이 이해심과 인내심을 가지고 환자의 편식을 교정하면서 가능한 한 편안한 식사분위기에서 급식하여야 한다.

또한 환자의 증세에 따라 필요한 비타민 및 무기질을 보충하며, 신체적인 건강상태와 질환에 따라 차별화된 식이요법을 행한다.

장기 입원을 요하는 정신질환자는 활동량이 비교적 적지만, 고단위 투약에 의한 내적 에너지 소모량이 크며, 환자 대부분이 병원 급식에만 의존하므로 보다 영양상 균형을 이룬 식사를 제공하여야 한다.

2. 식이요법 종류

가. 일반식(Regular Diet)

특별한 음식의 제한을 필요로 하지 않는 환자에게 적용되며, 한국인의 성인 영양섭취기준에 기본을 두고 환자의 좋은 영양상태에 필요한 식품을 적절한 양으로 공급하는 정상 식사이다. 일일 식품구성은 당뇨학회, 대한영양사회 및 한국영양학회에서 제정한 "식품교환표"를 기초로 사용한다.

영 양 기 준

열 량(Kcal)	탄수화물(g)	단백질(g)	지 방(g)
2,000~2,500	406	94	55

주 1) 열 량 : 65%내외 탄수화물, 15% 단백질, 20% 지방

2) 단백질 : 섭취량의 1/3은 양질의 단백질(동물성 단백질)로 공급

나. 일반 연식(Soft Diet)

신체적, 정신적 원인으로 인해 삼킴곤란이 있거나 소화장애가 있어 일반식에 적응이 불가능한 환자에게 제공하며, 소화되기 쉽도록 섬유질과 결체조직이 적은 식재료를 사용하고 강한 향신료 사용을 제한한다. 적절한 양을 섭취할 경우 영양적인 부족은 없으나 필요시 섭취량 증가를 위하여 간식을 제공할 수 있다.

다. 당뇨식 (Diabetic Diet)

부적절한 식습관과 생활습관을 바꾸어 혈당, 혈액내 지질, 혈압을 정상에 가깝게 조절하여 합병증을 예방하고 지연시켜 올바른 식습관 및 좋은 영양상태를 유지하는데 있다

라. 저염식 (Low Sodium Diet)

고혈압 및 고혈압이 동반된 당뇨, 신장 질환, 심장 질환 등의 합병증 환자에게 제공되는 식이로 적절한 혈압관리 및 좋은 영양상태를 유지하여 체력관리, 합병증의 예방 및 감소를 목적으로 제공한다.